

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA

Centro Materno-Infantil (sintético) — Consultorio de Obstetricia

FILIACIÓN

Nombre: PACIENTE SINTÉTICA - NO REAL
Edad: 32 años
Estado civil: Conviviente
Ocupación: Empleada administrativa
Fecha de elaboración: 16/04/2026

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

Fórmula obstétrica: G2 P1 (1 cesárea segmentaria, 2022)
Menarquia: 13 años. Régimen catamenial regular previo.
Gestación previa (2022): embarazo de 39 semanas, cesárea segmentaria por desproporción céfalo-pélvica. Recién nacido vivo, sexo femenino, 3,250 g, Apgar 8/9. Lactancia materna exclusiva 4 meses.
Complicación previa: anemia leve en tercer trimestre del embarazo anterior, manejada con sulfato ferroso oral.

GESTACIÓN ACTUAL

FUM: 15/09/2025
FPP: 22/06/2026
EG actual (por FUM): 28 semanas 2 días
Controles prenatales: 5 al momento
Centro de control: Mismo centro (continuidad)

Paciente refiere movimientos fetales presentes desde semana 20. No refiere sangrado, ni pérdida de líquido, ni contracciones. Sin signos de alarma al momento de la consulta.

LABORATORIOS (último control: 02/04/2026)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
Hemoglobina	10.8	g/dL	Anemia leve gestacional
TSH	2.1	mUI/L	Dentro de rango
Glucosa basal	92	mg/dL	Normal
HIV (ELISA)	No reactivo	—	Negativo
Sífilis (RPR)	No reactivo	—	Negativa

ECOGRAFÍA DE LAS 20 SEMANAS (28/01/2026)

Hallazgos: Feto único, vivo, en presentación cefálica al momento del estudio. Biometría acorde a edad gestacional. Peso fetal estimado: 380 g. Placenta posterior, grado 0, no oclusiva. Líquido amniótico en cantidad normal (ILA 14 cm). Anatomía fetal sin anomalías estructurales observables. Doppler de arterias uterinas dentro de límites normales.

EXAMEN FÍSICO ACTUAL

PA 110/70 mmHg. FC 78 lpm. T° 36.7°C. Peso 68.4 kg. Talla 1.58 m. AU 27 cm. LCF 142 lpm (Doppler). Edema MMII (-/-). No várices significativas.

PLAN

1. Continuar suplementación con sulfato ferroso 300 mg VO c/24h por anemia leve.
2. Continuar ácido fólico y calcio según pauta.
3. Control prenatal en 2 semanas.
4. Tamizaje de GBS programado entre las 35 y 37 semanas.
5. Educación sobre signos de alarma obstétricos.
6. Plan de parto: cesárea programada por cesárea previa, a coordinar a las 39 sem.